REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: PARANA
MUNICÍPIO: IBEMA

1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2026

EROILDA ALVES DE OLIVEIRA
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação
   - 1.1. Informações Territoriais
   - 1.2. Secretaria de Saúde
   - 1.3. Informações da Gestão
   - 1.4. Fundo de Saúde
   - 1.5. Plano de Saúde
   - 1.6. Informações sobre Regionalização
   - 1.7. Conselho de Saúde
2. Introdução
3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
   - 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
   - 3.2. Nascidos Vivos
   - 3.3. Principais causas de internação por local de residência
   - 3.4. Mortalidade por grupos de causas
4. Dados da Produção de Serviços no SUS
   - 4.1. Produção de Atenção Básica
   - 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
   - 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
   - 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
   - 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
   - 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
   - 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
   - 5.2. Por natureza jurídica
   - 5.3. Consórcios em saúde
6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
7. Programação Anual de Saúde - PAS
   - 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
9. Execução Orçamentária e Financeira
   - 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
   - 9.2. Indicadores financeiros
   - 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
   - 9.4. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar
10. Auditorias
11. Análises e Considerações Gerais

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	PR
Município	IBEMA
Região de Saúde	10ª RS Cascavel
Área	145,44 Km²
População	6.343 Hab
Densidade Populacional	44 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 23/05/2026

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SMS DE IBEMA
Número CNES	6772307
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	80881931000185
Endereço	RUA PARANAVAI S/N
Email	sms@pibema.pr.gov.br
Telefone	4532381865

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 23/05/2026

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	VIVIANE COMIRAN
Secretário(a) de Saúde cadastrado no período	EROILDA ALVES DE OLIVEIRA
E-mail secretário(a)	batis-frios@hotmail.com
Telefone secretário(a)	41988564125

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 23/05/2026
Período de referência: 01/01/2026 - 30/04/2026

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	08/1991
CNPJ	09.260.523/0001-41
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	Diogo Gawlik

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 23/05/2026

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2026-2029
Status do Plano	Aprovado

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 27/03/2026

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: 10ª RS Cascavel

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
ANAHY	102.648	2971	28,94
BOA VISTA DA APARECIDA	256.296	8023	31,30
BRAGANEY	343.321	4745	13,82
CAFELÂNDIA	271.724	20145	74,14
CAMPO BONITO	433.836	3997	9,21
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	275.748	14776	53,59
CASCAVEL	2100.105	368195	175,32
CATANDUVAS	581.754	10621	18,26
CORBÉLIA	529.385	17933	33,88
CÉU AZUL	1179.442	11255	9,54
DIAMANTE DO SUL	359.945	3147	8,74
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	326.446	4880	14,95
FORMOSA DO OESTE	275.712	7763	28,16
GUARANIAÇU	1225.607	13770	11,24
IBEMA	145.442	6343	43,61
IGUATU	106.937	2156	20,16
IRACEMA DO OESTE	81.538	2328	28,55
JESUÍTAS	247.496	10954	44,26
LINDOESTE	361.368	5217	14,44
NOVA AURORA	474.011	14331	30,23
QUEDAS DO IGUAÇU	821.503	31423	38,25
SANTA LÚCIA	116.857	3638	31,13
SANTA TEREZA DO OESTE	326.917	13938	42,63
TRÊS BARRAS DO PARANÁ	504.172	11157	22,13
VERA CRUZ DO OESTE	327.084	8178	25,00

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2025

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação	DECRETO	
Endereço	Rua Paranavaí	
E-mail		
Telefone		
Nome do Presidente	Luiz Narciso Talini	
Número de conselheiros por segmento	**Usuários**	4
	Governo	2
	Trabalhadores	2
	Prestadores	0

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Ano de referência:

- Considerações

O município de Ibema apresentou, entre os anos de 2010 e 2022, um crescimento populacional modesto de 2,51%, evidenciando relativa estabilidade demográfica ao longo do período. A densidade populacional permanece baixa, característica típica de municípios de pequeno porte com predominância de áreas rurais e ampla extensão territorial.

A população infantil, representada pelas crianças de 0 a 6 anos (10,04% do total), demonstra a manutenção de uma base populacional jovem, refletindo a necessidade contínua de investimentos em políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil, educação infantil, vacinação, acompanhamento do desenvolvimento infantil e ampliação da oferta de creches.

Os dados referentes ao número de domicílios e à média de moradores por residência também são fundamentais para subsidiar o planejamento municipal, contribuindo para a definição de estratégias nas áreas de infraestrutura urbana, saneamento básico, habitação, mobilidade e organização dos serviços públicos, especialmente no setor da saúde e assistência social.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

Este instrumento contempla as informações referentes as ações de saúde, suas pactuações e metas alcançadas, bem como prestação de contas financeiras no 1º quadrimestre de 2026

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2025

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	210	204	414
5 a 9 anos	236	236	472
10 a 14 anos	239	230	469
15 a 19 anos	217	220	437
20 a 29 anos	412	463	875
30 a 39 anos	398	418	816
40 a 49 anos	407	436	843
50 a 59 anos	408	427	835
60 a 69 anos	318	343	661
70 a 79 anos	169	183	352
80 anos e mais	72	97	169
Total	**3.086**	**3.257**	**6.343**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 22/05/2026.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2022	2023	2024
IBEMA	83	85	103

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 22/05/2026.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2022	2023	2024	2025	2026
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	49	38	97	51	17
II. Neoplasias (tumores)	87	93	63	59	12
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	18	10	7	4	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	10	13	16	7	3
V. Transtornos mentais e comportamentais	5	13	12	7	5
VI. Doenças do sistema nervoso	6	17	11	29	5
VII. Doenças do olho e anexos	5	10	8	2	1
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	1	1	2	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	69	106	158	155	18
X. Doenças do aparelho respiratório	127	97	128	116	18
XI. Doenças do aparelho digestivo	84	84	119	134	22
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	6	3	7	11	-

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	12	14	30	34	8
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	20	37	49	67	16
XV. Gravidez parto e puerpério	64	72	104	108	25
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	9	8	16	21	6
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	4	1	7	4	1
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	10	22	17	24	6
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	69	92	129	95	23
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	11	13	34	30	3
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**665**	**744**	**1.013**	**960**	**189**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 22/05/2026.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	5	2	1
II. Neoplasias (tumores)	8	6	13
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	3	2	5
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	-	-
VI. Doenças do sistema nervoso	3	1	2
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	12	11	18
X. Doenças do aparelho respiratório	10	8	9
XI. Doenças do aparelho digestivo	2	6	3
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	-	1
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	1
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	1	3	1
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	1
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	1	-
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	1	-
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	-	-	-
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	7	10	13
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-
Total	**52**	**51**	**68**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 22/05/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A redução das mortes por causas sensíveis à Atenção Primária à Saúde depende do fortalecimento das ações de prevenção, da qualificação da assistência e da

garantia de acesso oportuno e resolutivo à Rede de Atenção à Saúde. Nesse contexto, destacam-se as seguintes estratégias:

1. Promoção da saúde e prevenção de doenças

A promoção da saúde constitui um dos principais pilares para a redução de óbitos evitáveis. A manutenção de elevadas coberturas vacinais é fundamental para prevenir doenças imunopreveníveis, como sarampo, coqueluche, influenza, COVID-19 e hepatites. Paralelamente, ações educativas voltadas à adoção de hábitos saudáveis ¿ incluindo alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, higiene adequada, combate ao tabagismo e redução do consumo abusivo de álcool ¿ contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população.

Também merecem destaque as ações de vigilância epidemiológica e controle de vetores, especialmente relacionadas à dengue, zika e chikungunya, além do monitoramento contínuo de surtos e da busca ativa de casos e contatos.

2. Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde

A Atenção Primária à Saúde desempenha papel essencial na prevenção de agravos, complicações e mortes evitáveis, sendo a principal porta de entrada e coordenadora do cuidado no sistema de saúde.

O acompanhamento contínuo de pessoas com hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, por meio de consultas periódicas, adesão ao tratamento medicamentoso, realização de exames de rotina e elaboração de plano terapêutico individualizado, contribui significativamente para a redução de complicações e internações.

O pré-natal qualificado, iniciado precocemente e realizado de forma adequada, possibilita a identificação de fatores de risco, a realização dos exames necessários, o acompanhamento da gestante e os encaminhamentos oportunos, reduzindo riscos maternos e infantis.

Na saúde da criança, são fundamentais as ações de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, incentivo ao aleitamento materno, orientação alimentar, vacinação e manejo precoce de diarréias e infecções respiratórias. Já na saúde do idoso, destacam-se o controle das doenças crônicas, a imunização, a prevenção de quedas e o fortalecimento do suporte familiar e comunitário.

Além disso, a qualificação permanente das equipes de saúde, associada à implantação de protocolos clínicos e linhas de cuidado, amplia a capacidade de resposta das unidades e fortalece a resolutividade da assistência.

3. Ampliação do acesso aos serviços especializados e hospitalares

A integração entre os diferentes níveis de atenção é indispensável para garantir continuidade e integralidade do cuidado. O encaminhamento ágil de pacientes com sinais de risco ou complicações, identificado na Atenção Primária, reduz o tempo de resposta e evita agravamentos clínicos.

Uma regulação eficiente e articulada contribui para assegurar acesso oportuno a consultas especializadas, exames diagnósticos e leitos hospitalares, fortalecendo a capacidade assistencial da rede. Da mesma forma, a integração entre unidades básicas, serviços de urgência e emergência e hospitais favorece melhores desfechos clínicos e maior segurança ao paciente.

4. Gestão, monitoramento e avaliação em saúde

O monitoramento sistemático dos óbitos por causas sensíveis permite identificar os agravos mais prevalentes no município, como acidente vascular cerebral (AVC), pneumonias, complicações do parto e doenças crônicas descompensadas.

A utilização de sistemas de informação em saúde, como SIM, e-SUS e Relatório Anual de Gestão (RAG), possibilita a análise de indicadores epidemiológicos e assistenciais, subsidiando o planejamento estratégico e a tomada de decisões baseadas em evidências.

A educação permanente em saúde também representa ferramenta fundamental para atualização técnica das equipes e melhoria contínua da qualidade da assistência prestada.

5. Ações intersetoriais e enfrentamento das vulnerabilidades

A melhoria das condições de saneamento básico, acesso à água potável, coleta adequada de resíduos e habitação contribui diretamente para a redução de doenças infecciosas e agravos evitáveis.

Da mesma forma, ações articuladas com os setores da educação e assistência social fortalecem o cuidado integral, ampliam o acesso da população aos serviços públicos e auxiliam na redução das vulnerabilidades sociais associadas ao adoecimento e à mortalidade precoce.

Em síntese, a maior parte das mortes por causas sensíveis pode ser evitada por meio de políticas públicas integradas, ações efetivas de promoção da saúde e prevenção de doenças, acompanhamento contínuo das condições crônicas, ampliação da cobertura vacinal, diagnóstico precoce e acesso oportuno ao tratamento, com integração eficiente entre Atenção Primária, serviços de urgência e rede hospitalar.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	2.077
Atendimento Individual	6.559
Procedimento	11.162
Atendimento Odontológico	490

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	-	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/05/2026.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril
2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto
3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	-	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-

05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/05/2026.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril
2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto
3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Não há informações cadastradas para o período
Data da consulta: 23/05/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

Neste quadro verificarmos a falta de dados. Segue abaixo alguns dados retirados do E-sus que contemplam as informações:

Procedimentos	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	Total
Aferição de PA	0	0	223	30	253
Aferição de temperatura	0	0	223	30	253
Curativo simples	0	0	44	3	47
Glicemia capilar	0	0	31	6	37
Medição de altura	0	0	224	30	254
Medição de peso	0	0	224	30	254
Total	0	0	969	129	1.098

atendimentos médicos no hospital municipal de janeiro a abril de 2026: 3.938

atendimentos da enfermagem no hospital municipal de janeiro a abril de 2026: 1.742

atendimentos médicos na UBS e USF de janeiro a abril de 2026: 4.953

atendimentos da enfermagem na UBS e USF de janeiro a abril de 2026: 965

OBS: os dados do meses de janeiro, fevereiro e abril/26 não estão completos devido uma falha na transmissão de dados.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 04/2026

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
HOSPITAL GERAL	0	1	0	1
POLO ACADEMIA DA SAUDE	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	2	2
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	1	0	1
Total	**0**	**2**	**4**	**6**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 23/05/2026.

5.2. Por natureza jurídica

Período 04/2026

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	4	1	0	5
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
ASSOCIACAO PRIVADA	0	1	0	1
Total	**4**	**2**	**0**	**6**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 23/05/2026.

5.3. Consórcios em saúde

Período 2026

Participação em consórcios			
CNPJ	**Natureza**	**Area de atuação**	**Participantes**
03273207000128	Direito Público	Compra de medicamentos	PR / IBEMA
17420047000107	Direito Público	Urgência e emergência	PR / IBEMA
00944673000108	Direito Público	Atenção psicossocial Atenção odontológica Urgência e emergência Atenção hospitalar Serviços de apoio ao diagnóstico Consulta médica especializada	PR / IBEMA

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 23/05/2026.

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

  O município de Ibema conta hoje com um Hospital Municipal e com duas Unidades básicas de saúde. Nestas contemplam uma Equipe saúde da família e Duas EAP's.

O município ainda tem Uma Unidade de fisioterapia e uma academia de saúde.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2026

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	4	3	6	11	7

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	1	0	3	1	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 10/06/2026.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	1	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	48	53	54	45
	Residentes e estagiários (05, 06)	5	5	5	5

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	3	4	3	4

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 10/06/2026.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

  O município possui hoje os seguinte profissionais:

  Hospital com 26 profissionais sendo estes: 10 terceirizados; 11 concursados, 3 contratados e 03 estagiarios;

  UBS com 18 profissionais sendo estes: 12 concursados, 2 contratados e 2 estagiários

  ESF com 22 profissionais sendo estes: 03 terceirizados; 15 concursados, 1 contratado e 01 estagiario;

  Secretaria de saúde com 17 profissionais sendo estes: 13 concursados, 2 contratados e 01 estagiário;

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

OBJETIVO Nº 1 .1 - Garantia do acesso da população a serviços de saúde de qualidade, mediante estruturação e investimentos na Rede de Serviços da Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2026-2029)	Meta 2026	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Implementar um programa Municipal de Requalificação física das Unidades de Saúde contendo adequação de salas de atendimento, garantir privacidade, conforto térmico, ventilação, iluminação, acessibilidade para deficientes e pessoas com mobilidade reduzida.	Unidades de saude requalificadas	Número	2025	0		Não programada	Número		☑ Sem Apuração	
2. Manutenção continua das Unidades de Saúde (UBS, USF, VISA e Hospital) com cronograma de execução	Unidades de saude requalificadas	Número	2025			Não programada	Número		☑ Sem Apuração	
3. Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos permanentes com cronograma de execução	Percentual de equipamentos permanentes com manutenção preventiva/corretiva realizado	Percentual	2025	100,00		100,00	Percentual		0	0
Ação Nº 1 - Executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos permanentes da rede municipal de saúde										
4. Aquisição de equipamentos de informática (impressoras, computadores, nobreak) para informatização do SUS	Percentual de unidades de saúde informatizada com equipamentos de informáticas adequados e em funcionamento	Percentual	2025			Não programada	Percentual		☑ Sem Apuração	
5. Aquisição e substituição de mobiliários e equipamentos que estejam deteriorados, visando garantir ergonomia, segurança e qualidade no atendimento.	Percentual de mobiliários e equipamentos substituídos ou adquiridos conforme diagnostico de necessidades de unidades de saude	Percentual				Não programada	Percentual		☑ Sem Apuração	

6. Comissão para avaliar quais pacientes que precisam de veículo exclusivo para atendimento fora do município	Criar comissão	Percentual				Não programada	Percentual		☑ Sem Apuração	
7. Estabelecer um processo regulatório eficiente e transparente para gerenciar e monitorar os encaminhamentos dentro da organização ou sistema	Criar processo	Número				Não programada	Número		☑ Sem Apuração	
8. Implementação do Registro Digital de Atestados, Receituários e Encaminhamentos no SUS Digital	Criar processo	Percentual	2025			Não programada	Percentual		☑ Sem Apuração	
9. Criar e implementar, no calendário institucional, o “Dia do Cuidado”, destinado à promoção da saúde física e mental dos profissionais de saúde, com ações focadas em bem-estar, prevenção de adoecimento e valorização das equipes.	Criar calendário	Número				Não programada	Número		☑ Sem Apuração	
10. Disponibilizar um motorista dedicado para realizar o transporte, entrega e recolhimento dos veículos utilizados pelas unidades de saúde (UBS, USF e VISA), garantindo maior agilidade e organização no fluxo de trabalho das equipes.	Disponibilizar motorista	Número	2025			1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Designar motorista para exercer função										

11. Implementar um sistema de agendamento de consultas que permita ao paciente marcar seu atendimento com antecedência, eliminando a necessidade de comparecer de madrugada para retirar fichas e garantindo maior organização no fluxo de atendimento.	Percentual de consultas agendadas previamente	Percentual				50,00	Percentual		28,01	56,02
Ação Nº 1 - Criar agenda para realizar ação										
12. Assegurar o direito do idoso de contar com a presença de um acompanhante durante viagens em transporte coletivo no município de Cascavel, promovendo segurança, conforto e acessibilidade no deslocamento	Percentual de viagens em transporte sanitário realizado por idosos com acompanhante autorizado	Percentual	2025			100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Assegurar o direito do idoso										
13. Aquisição de equipamentos no âmbito da saúde digital e telessaúde (computador portátil, televisor e câmera)	Quantidade de equipamento de telessaude	Número				1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Realizar a aquisição e implantação										
14. Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde (espirômetro, ultrassom, TENS e FES, tábua, DEA, cadeira de rodas, otoscópio, ultrassom p/ fisioterapia, câmara p/ imunobiológico, doppler vascular, balança digital, fotóforo, dinamômetro, bisturi elétrico, eletrocardógrafo, dermatoscópio, retinógrafo e laser p/ fisioterapia	Quantidade de equipamento adquirido	Número	2025			1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Realizar a aquisição e implantação										

OBJETIVO Nº 1 .2 - Promoção da atenção integral à saúde da população através das Equipes da APS, Saúde da Família, Saúde Bucal e E-MULTI para todos os segmentos populacionais, priorizando as ações para a população mais vulnerável (criança, mulher, adolescentes e jovens, saúde do homem e idosos, seguido da promoção da atenção integral à Saúde Bucal e da adesão à assistência em Redes de Atenção à Saúde a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2026-2029)	Meta 2026	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Contratação de Nutricionista e educador física.	Realizar concurso publico	Número	2025			Não programada	Número		☑ Sem Apuração	
2. Instituir oficialmente os cargos de Técnico de Enfermagem e Auxiliar de farmácia no quadro funcional do município, garantindo funções definidas, atribuições regulamentadas e remuneração compatível com as responsabilidades exercidas.	Realizar concurso publico	Número	2025			Não programada	Número		☑ Sem Apuração	
3. Ampliar em 100% a cobertura de ESF (Equipe Saúde da Família) no município de Ibema.	Realizar concurso publico	Percentual		50,00		Não programada	Percentual		☑ Sem Apuração	
4. Manter o Planifica sus	Percentual de Participações das capacitações	Percentual	2025	100,00		100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Aumentar o número de participações em capacitações do Planificasus										
5. Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres com idade entre 40 a 69 anos.	Taxa de cobertura de mamografias em relação à população de mulheres de 40 a 69 anos	Razão	2025	0,29		0,30	Razão		☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Ampliar o número de mamografias no ano										
6. Aumentar a proporção de pessoas hipertensas cadastradas nas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) de Ibema com registro de consulta, aferição da pressão arterial, antropometria, visita domiciliar nos últimos seis meses.	Percentual de Pessoas Cadastradas com Hipertensão em Acompanhamento Integral na APS no período	Percentual	2025	64,00		65,00	Percentual		66,10	101,69
Ação Nº 1 - Aumentar para 80% a proporção de pessoas hipertensas cadastradas nas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS)										
7. Aumentar o número de pessoas cadastradas com Diabetes em acompanhamento semestral regular na Atenção Primária à Saúde, com registro de consulta, aferição de pressão, antropometria, solicitação ou avaliação de Hemoglobina Glicada, visita do ACS e avaliação do pé diabético.	Percentual de Pessoas Cadastradas com Diabetes em Acompanhamento Integral na APS no período	Percentual	2025	64,00		65,00	Percentual		68,20	104,92

Ação Nº 1 - Alcançar mínimo de 80% o percentual de pessoas cadastradas com Diabetes										
8. Aumentar o número de gestantes residentes em Ibema com captação precoce para o pré-natal (início das consultas até a 12ª semana de gestação) com exames de TR realizados	Percentual de Gestantes com Início do Pré-natal até a 12ª Semana de Gestação	Percentual	2025	92,00		93,00	Percentual		93,00	100,00
Ação Nº 1 - Aumentar e/ou manter, no mínimo, 92% das gestantes residentes em Ibema com captação precoce para o pré-natal										
9. Elevar e/ou manter percentual de gestantes com 07 ou mais consultas de pré natal com aferição de pressão arterial, peso e altura, visita de ACS, vacinação de dTpa, registro ou exames avaliados de sífilis e HIV no terceiro trimestre.	Porcentagem de Nascidos Vivos de mães com 7 ou mais.	Percentual	2025	92,00		93,00	Percentual		93,00	100,00
Ação Nº 1 - Elevar e/ou manter percentual de gestantes com 07 ou mais consultas de pré natal.										
10. Elevar e/ou manter percentual de puérperas com 01 ou mais consultas de puerpério e visita de ACS	Porcentagem de Nascidos Vivos de mães com 7 ou mais.	Percentual	2025	92,00		93,00	Percentual		93,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementação de Programas de Acompanhamento das Puérperas										
11. Aumentar o número de gestantes com, no mínimo, uma consulta odontológica realizada na Atenção Básica.	Percentual de gestantes com pelo menos uma consulta odontológica na atenção básica.	Percentual	2025	64,00		70,00	Percentual		64,00	91,43
Ação Nº 1 - Implementação de Campanha de Conscientização e Agendamento de Consultas Odontológicas para Gestantes										
12. Elevar em 30% o número de primeiras consultas odontológicas realizadas na Atenção Primária a cada ano.	Percentual de Pessoas Cadastradas com Primeira Consulta Odontológica Programada na APS (N° de pessoas cadastradas na APS com registro de 1ª consulta odontológica no período/N° total de pessoas cadastradas X 100).	Percentual	2025	9,00		10,00	Percentual		10,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementação de Programa de Acolhimento Odontológico para Novos Usuários										

13. Alcançar mínimo de 30% a proporção de tratamentos odontológicos concluídos na Atenção Primária à Saúde (APS) de Ibema.	Proporção de Tratamentos Odontológicos Concluídos na APS (N° de tratamentos odontológicos concluídos/N° de tratamentos odontológicos iniciados x 100).	Percentual	2025			10,00	Percentual		10,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementação de Programa de Acompanhamento e Monitoramento de Tratamentos Odontológicos										
14. Atingir e manter, uma cobertura vacinal igual ou superior a 90% para a vacina da Influenza (H1N1) em idosos (60 anos ou mais)no município.	Percentual de cobertura vacinal de Influenza (H1N1) em idosos.	Percentual	2025	90,00		90,00	Percentual		35,44	39,38
Ação Nº 1 - Mobilização e Intensificação das Campanhas de Vacinação para Idosos com Ações de Acesso Facilitado										
15. Alcançar/Manter em no mínimo 95% a cobertura vacinal das crianças menores de 01 ano de idade.	Percentual de cobertura vacinal para o público alvo.	Percentual	2025	95,00		95,00	Percentual		95,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementação de Estratégia de Acompanhamento Intensivo e Agendamento Ativo das Vacinas para Crianças Menores de 1 Ano										
16. Aumentar o número de pessoas idosas cadastradas com acompanhamento anual regular na Atenção Primária à Saúde, com registro de consulta, aferição de pressão, antropometria e visita do ACS	Percentual de Pessoas Cadastradas idosas em Acompanhamento	Percentual	2025			65,00	Percentual		65,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementação de um Programa de Cuidado Completo e Acompanhamento										
17. Aumentar o número de crianças cadastradas com acompanhamento regular na Atenção Primária à Saúde, com registro de uma consulta até o 30º dia de vida, ter pelo menos nove consultas até dois anos de vida com aferição antropometria e visita do ACS	Percentual de crianças em Acompanhamento	Percentual	2025			65,00	Percentual		65,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementação de um Programa de Cuidado Completo e Acompanhamento										

18. Incremento ao custeio de serviços da atenção primária à saúde (aquisição de pequenos acessórios de suporte(cabos, microfones, câmeras, fones, teclados, tripés),observando que são itens de custeio e não de capital, identificação e acompanhamento de idosos em situação de vulnerabilidade ou com restrição de mobilidade(transporte, epis e materiais clínicos), capacitação dos profissionais da aps em estratégias de promoção da saúde e educação alimentar e nutricional, aquisição de insumos e materiais de uso contínuo, aquisição de insumos e materiais de uso contínuo para acompanhamento de pessoas com condições crônicas)	Quantidade de incremento	Número	2025			1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Incrementar o custeio e aprimoramento da infraestrutura da Atenção Primária à Saúde (APS),										
19. Custeio de serviços da atenção primária à saúde (estratégia de rastreamento e controle de condições crônicas e estratégias para atenção integral à saúde da mulher	Quantidade de incremento	Número	2025			1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Incrementar o custeio e aprimoramento da infraestrutura da Atenção Primária à Saúde (APS),										

OBJETIVO Nº 1 .3 - Promoção da atenção à Saúde Mental, álcool e outras drogas, seguido da adesão à assistência em Redes de Atenção a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2026-2029)	Meta 2026	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Criar e estruturar uma equipe de saúde mental composta por profissionais qualificados, capacitados para oferecer atendimento integral, humanizado e baseado em evidências, atendendo às demandas da população de forma contínua e articulada com a rede de atenção psicossocial - QUALICIS	Realizar concurso publico ou contratação	Número	2025			Não programada	Número		☑ Sem Apuração	
2. Manter convênio com o SIM PR	Garantir o acesso	Número	2025	1		1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento e Ampliação da Parceria com o SIM PR										

OBJETIVO Nº 1 .4 - Garantir o acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica conforme RENAME (Relação Nacional dos Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica) - Bloco da Assistência farmacêutica

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2026-2029)	Meta 2026	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Implementar um serviço especializado de acompanhamento farmacêutico para pacientes que utilizam múltiplos medicamentos (polimedicamentos), visando melhorar a adesão ao tratamento, reduzir riscos de interações medicamentosas e promover o uso racional de fármacos.	Melhoria na assistência farmacêutica	Número	2025			Não programada	Número		☑ Sem Apuração	
2. Atualizar e manter REMUME (relação Municipal de Medicamentos)	Melhoria na assistência farmacêutica	Número	2025	1		Não programada	Número		☑ Sem Apuração	
3. Assegurar a continuidade do convênio com o consórcio Paraná de medicamentos responsável pelo fornecimento de medicamentos, garantindo abastecimento regular e acesso contínuo aos fármacos essenciais para a população do município.	Melhoria na assistência farmacêutica	Número	2025	1		1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Assegurar a continuidade do convênio com o Consórcio Paraná de Medicamentos										

OBJETIVO Nº 1 .5 - Assegurar a execução das ações de vigilância em saúde, e a integração das equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária com as equipes Saúde da Família na atenção a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, das não transmissíveis e das imunopreveníveis, bem como às emergências; e que juntas fortaleçam a promoção da saúde, a Vigilância em Saúde Ambiental e da Saúde do Trabalhador.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2026-2029)	Meta 2026	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Atualizar 100% dos dados de cadastro da Unidade e dos Agentes de Vigilância Sanitária	Atualizar 100% dos dados de cadastro da Unidade e dos Agentes de Vigilância Sanitária Cadastro atualizado	Percentual	2025	100,00		100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Atualização Completa do Cadastro da Unidade e dos Agentes de Vigilância Sanitária										
2. Implantar e manter ativo o Núcleo Municipal de Segurança do Paciente	Garantia do acesso	Número	2025	1		1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - implementar e melhorar continuamente as ações relacionadas à segurança do paciente										
3. Realizar atividades de educação permanente em saúde do trabalhador (EPST) para os profissionais da atenção e/ou da vigilância em saúde duas vezes ao ano	Capacitar	Número	2025	2		2	Número		0	0
Ação Nº 1 - Treinar equipe de trabalhador										

4. Investigar 100% os acidentes de trabalho típicos que resultam em óbito e amputação, e típicos e de trajeto com crianças e adolescentes	Percentual de investigação	Percentual	2025	100,00		100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementação de Investigação Completa e Sistematizada de Acidentes de Trabalho Típicos e de Trajeto com Óbito e Amputação										
5. Atingir mais de 90% de contatos de casos novos de hanseníase examinados no ano de diagnóstico	Contato examinados	Percentual	2025	90,00		91,00	Percentual		91,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementação de Estratégia de Monitoramento Ativo para Casos Novos de Hanseníase no Ano de Diagnóstico										
6. Aumentar a cobertura populacional de acompanhamento do estado nutricional, com meta escalonada de acordo com a linha de base	Proporção de população acompanhada quanto ao estado nutricional	Percentual	2025	64,00		65,00	Percentual		65,00	100,00
Ação Nº 1 - Verificação de SSVV em todas as triagens de forma completa										
7. Atingir 40% ou mais de mulheres com idade entre 25 e 64 anos, com coleta de citopatológico do colo do útero, que realizaram ao menos 1 exame no intervalo de 3 anos	Proporção de população acompanhada quanto ao estado nutricional	Percentual	2025			41,00	Percentual		☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Realizar busca ativa permanente										
8. Realizar o monitoramento entomológico por meio do uso de ovitrampas instaladas em 100% do território do município em no mínimo 50% das semanas epidemiológicas do ano	Percentual de Ovitrampas Verificadas Regularmente	Percentual	2025	100,00		100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Assegurar que todas as ovitrampas sejam montadas e instaladas de forma padronizada, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde para garantir a validade dos dados										
9. Atingir 85% do número mínimo mensal de análises para os parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez, conforme a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e inseridas no Sisagua	Percentual de análises realizadas	Percentual	2025			85,00	Percentual		85,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter um mapa atualizado dos pontos de coleta, com suas coordenadas geográficas e características, para garantir a representatividade das amostras										
10. Investigar 93% ou mais dos óbitos de crianças menores de um ano de idade	Percentual de óbitos investigados	Percentual	2025			94,00	Percentual		100,00	106,38
Ação Nº 1 - Participar de todas as reuniões do comitê de investigação										
11. Alcançar 75% de homogeneidade vacinal para no mínimo 6 vacinas	Percentual de cobertura vacinal	Percentual	2025			75,00	Percentual		☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Intensificar a busca ativa de faltosos										

12. Realizar projeto saúde na escola trabalhando temas como ações de combate ao Aedes Aegypti, alimentação saudável, prevenção da violência e promoção da Cultura da Paz, Saúde mental, Saúde sexual e reprodutiva e atividades de escovação dental supervisionada e verificação da situação vacinal	Saúde na escola	Número	2025	1		1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar professores, coordenadores pedagógicos e pais para atuarem como agentes multiplicadores de informações e estratégias de prevenção dentro do ambiente escolar e familiar										

DIRETRIZ Nº 2 - RELACIONADO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC E A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

OBJETIVO Nº 2 .1 - Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade (atenção especializada) e implantar o processo de monitoramento e avaliação dos encaminhamentos conforme classificação de risco dos pacientes.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2026-2029)	Meta 2026	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Implementar capacitações contínuas para toda a equipe de saúde e acolhimento, abordando classificação de risco, atendimento inicial em emergências, atendimento humanizado e protocolos atualizados de urgência e emergência, visando qualificar o cuidado prestado e padronizar condutas assistenciais	Garantia do acesso	Número	2025			2	Número		☑ Sem Apuração	

Ação Nº 1 - Garantir qualificação contínua da equipe de saúde e acolhimento

OBJETIVO Nº 2 .2 - Garantir o acesso da população aos serviços de Urgência e Emergência, conforme a construção da Rede de Urgência e Emergência que está sendo estruturada em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e com o Ministério da Saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2026-2029)	Meta 2026	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Assegurar a manutenção da equipe mínima necessária de enfermagem — composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem — garantindo a presença de ao menos um enfermeiro em todos os plantões, de forma a manter o funcionamento contínuo, seguro e qualificado do serviço hospitalar.	Garantia do acesso	Percentual	2025	100,00		100,00	Percentual		100,00	100,00

Ação Nº 1 - Garantir equipe mínima através de concurso ou contratação

DIRETRIZ Nº 3 - RELACIONADO À GESTÃO EM SAÚDE

OBJETIVO Nº 3 .1 - Aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão descentralizada e regionalizada, Gestão do Planejamento e da informação em saúde, Gestão do trabalho e da educação na saúde, e aperfeiçoamento e fortalecimento da Gestão Participativa e do Controle Social.										
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2026-2029)**	**Meta 2026**	**Unidade de medida - Meta**	**Polaridade**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter convênio com o CISOP.	Garantir o acesso	Número	2025	1		1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento e Ampliação da Parceria com o CISOP										
2. Manter convênio com Sistema GSUS (via estado) para agendamentos de exames e consultas de alta complexidade	Garantir o acesso	Número	2025	1		1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento e Ampliação da Parceria com o GSUS										

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção			
Subfunções	**Descrição das Metas por Subfunção**	**Meta programada para o exercício**	**Resultados do Quadrimestre**
122 - Administração Geral	Manter convênio com o CISOP.	1	1
	Manter convênio com Sistema GSUS (via estado) para agendamentos de exames e consultas de alta complexidade	1	1
301 - Atenção Básica	Implantar e manter ativo o Núcleo Municipal de Segurança do Paciente	1	1
	Manter convênio com o SIM PR	1	1
	Assegurar a continuidade do convênio com o consórcio Paraná de medicamentos responsável pelo fornecimento de medicamentos, garantindo abastecimento regular e acesso contínuo aos fármacos essenciais para a população do município.	1	1
	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos permanentes com cronograma de execução	100,00	0,00
	Manter o Planifica sus	100,00	100,00
	Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres com idade entre 40 a 69 anos.	0,30	
	Aumentar a cobertura populacional de acompanhamento do estado nutricional, com meta escalonada de acordo com a linha de base	65,00	65,00
	Aumentar a proporção de pessoas hipertensas cadastradas nas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) de Ibema com registro de consulta, aferição da pressão arterial, antropometria, visita domiciliar nos últimos seis meses.	65,00	66,10
	Atingir 40% ou mais de mulheres com idade entre 25 e 64 anos, com coleta de citopatológico do colo do útero, que realizaram ao menos 1 exame no intervalo de 3 anos	41,00	
	Aumentar o número de pessoas cadastradas com Diabetes em acompanhamento semestral regular na Atenção Primária à Saúde, com registro de consulta, aferição de pressão, antropometria, solicitação ou avaliação de Hemoglobina Glicada, visita do ACS e avaliação do pé diabético.	65,00	68,20
	Aumentar o número de gestantes residentes em Ibema com captação precoce para o pré-natal (início das consultas até a 12ª semana de gestação) com exames de TR realizados	93,00	93,00
	Elevar e/ou manter percentual de gestantes com 07 ou mais consultas de pré natal com aferição de pressão arterial, peso e altura, visita de ACS, vacinação de dTpa, registro ou exames avaliados de sífilis e HIV no terceiro trimestre.	93,00	93,00
	Elevar e/ou manter percentual de puérperas com 01 ou mais consultas de puerpério e visita de ACS	93,00	93,00
	Disponibilizar um motorista dedicado para realizar o transporte, entrega e recolhimento dos veículos utilizados pelas unidades de saúde (UBS, USF e VISA), garantindo maior agilidade e organização no fluxo de trabalho das equipes.	1	0
	Alcançar 75% de homogeneidade vacinal para no mínimo 6 vacinas	75,00	

	Implementar um sistema de agendamento de consultas que permita ao paciente marcar seu atendimento com antecedência, eliminando a necessidade de comparecer de madrugada para retirar fichas e garantindo maior organização no fluxo de atendimento.	50,00	28,01
	Aumentar o número de gestantes com, no mínimo, uma consulta odontológica realizada na Atenção Básica.	70,00	64,00
	Realizar projeto saúde na escola trabalhando temas como ações de combate ao Aedes Aegypti, alimentação saudável, prevenção da violência e promoção da Cultura da Paz, Saúde mental, Saúde sexual e reprodutiva e atividades de escovação dental supervisionada e verificação da situação vacinal	1	1
	Assegurar o direito do idoso de contar com a presença de um acompanhante durante viagens em transporte coletivo no município de Cascavel, promovendo segurança, conforto e acessibilidade no deslocamento	100,00	100,00
	Elevar em 30% o número de primeiras consultas odontológicas realizadas na Atenção Primária a cada ano.	10,00	10,00
	Alcançar mínimo de 30% a proporção de tratamentos odontológicos concluídos na Atenção Primária à Saúde (APS) de Ibema.	10,00	10,00
	Aquisição de equipamentos no âmbito da saúde digital e telessaúde (computador portátil, televisor e câmera)	1	0
	Atingir e manter, uma cobertura vacinal igual ou superior a 90% para a vacina da Influenza (H1N1) em idosos (60 anos ou mais)no município.	90,00	35,44
	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde (espirômetro, ultrassom, TENS e FES, tábua, DEA, cadeira de rodas, otoscópio, ultrassom p/ fisioterapia, câmara p/ imunobiológico, doppler vascular, balança digital, fotóforo, dinamômetro, bisturi elétrico, eletrocardógrafo, dermatoscópio, retinógrafo e laser p/ fisioterapia	1	0
	Alcançar/Manter em no mínimo 95% a cobertura vacinal das crianças menores de 01 ano de idade.	95,00	95,00
	Aumentar o número de pessoas idosas cadastradas com acompanhamento anual regular na Atenção Primária à Saúde, com registro de consulta, aferição de pressão, antropometria e visita do ACS	65,00	65,00
	Aumentar o número de crianças cadastradas com acompanhamento regular na Atenção Primária à Saúde, com registro de uma consulta até o 30º dia de vida, ter pelo menos nove consultas até dois anos de vida com aferição antropometria e visita do ACS	65,00	65,00
	Incremento ao custeio de serviços da atenção primária à saúde (aquisição de pequenos acessórios de suporte(cabos, microfones, câmeras, fones, teclados, tripés),observando que são itens de custeio e não de capital, identificação e acompanhamento de idosos em situação de vulnerabilidade ou com restrição de mobilidade(transporte, epis e materiais clínicos), capacitação dos profissionais da aps em estratégias de promoção da saúde e educação alimentar e nutricional, aquisição de insumos e materiais de uso contínuo, aquisição de insumos e materiais de uso contínuo para acompanhamento de pessoas com condições crônicas)	1	0
	Custeio de serviços da atenção primária à saúde (estratégia de rastreamento e controle de condições crônicas e estratégias para atenção integral à saúde da mulher	1	0
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Implementar capacitações contínuas para toda a equipe de saúde e acolhimento, abordando classificação de risco, atendimento inicial em emergências, atendimento humanizado e protocolos atualizados de urgência e emergência, visando qualificar o cuidado prestado e padronizar condutas assistenciais	2	
	Assegurar a manutenção da equipe mínima necessária de enfermagem — composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem — garantindo a presença de ao menos um enfermeiro em todos os plantões, de forma a manter o funcionamento contínuo, seguro e qualificado do serviço hospitalar.	100,00	100,00
304 - Vigilância Sanitária	Atualizar 100% dos dados de cadastro da Unidade e dos Agentes de Vigilância Sanitária	100,00	100,00
	Realizar atividades de educação permanente em saúde do trabalhador (EPST) para os profissionais da atenção e/ou da vigilância em saúde duas vezes ao ano	2	0
	Investigar 100% os acidentes de trabalho típicos que resultam em óbito e amputação, e típicos e de trajeto com crianças e adolescentes	100,00	100,00
	Atingir 85% do número mínimo mensal de análises para os parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez, conforme a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e inseridas no Sisagua	85,00	85,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Atingir mais de 90% de contatos de casos novos de hanseníase examinados no ano de diagnóstico	91,00	91,00
	Aumentar a cobertura populacional de acompanhamento do estado nutricional, com meta escalonada de acordo com a linha de base	65,00	65,00
	Atingir 40% ou mais de mulheres com idade entre 25 e 64 anos, com coleta de citopatológico do colo do útero, que realizaram ao menos 1 exame no intervalo de 3 anos	41,00	
	Realizar o monitoramento entomológico por meio do uso de ovitrampas instaladas em 100% do território do município em no mínimo 50% das semanas epidemiológicas do ano	100,00	100,00
	Investigar 93% ou mais dos óbitos de crianças menores de um ano de idade	94,00	100,00

	Alcançar 75% de homogeneidade vacinal para no mínimo 6 vacinas	75,00	
	Realizar projeto saúde na escola trabalhando temas como ações de combate ao Aedes Aegypti, alimentação saudável, prevenção da violência e promoção da Cultura da Paz, Saúde mental, Saúde sexual e reprodutiva e atividades de escovação dental supervisionada e verificação da situação vacinal	1	1
306 - Alimentação e Nutrição	Aumentar a cobertura populacional de acompanhamento do estado nutricional, com meta escalonada de acordo com a linha de base	65,00	65,00
	Realizar projeto saúde na escola trabalhando temas como ações de combate ao Aedes Aegypti, alimentação saudável, prevenção da violência e promoção da Cultura da Paz, Saúde mental, Saúde sexual e reprodutiva e atividades de escovação dental supervisionada e verificação da situação vacinal	1	1

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	**Categoria Econômica**	**Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)**	**Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)**	**Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)**	**Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)**	**Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)**	**Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)**	**Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)**	**Outros recursos destinados à Saúde (R$)**	**Total(R$)**
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	3.552.200,00	1.215.000,00	60.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	4.827.200,00
	Capital	N/A	9.000,00	N/A	170.000,00	N/A	N/A	N/A	10.000,00	189.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	4.421.100,00	N/A	209.900,00	N/A	N/A	N/A	200.000,00	4.831.000,00
	Capital	N/A	264.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.000,00	274.500,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	200.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200.000,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	84.300,00	17.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	101.300,00
	Capital	N/A	1.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	79.000,00	138.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	217.000,00
	Capital	N/A	1.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 10/06/2026.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A Programação Anual de Saúde (PAS) aprovada para o exercício de 2026 foi construída de acordo com as diretrizes do Plano Municipal de Saúde e em consonância com as prioridades pactuadas nas instâncias de gestão do SUS. Observa-se que as metas propostas contemplam os principais problemas de saúde identificados no diagnóstico situacional, especialmente no que se refere ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, vigilância em saúde, promoção da saúde e melhoria da gestão do sistema.

No processo de monitoramento, destacou-se o empenho das equipes multiprofissionais, a articulação intersetorial e o acompanhamento pelo Conselho Municipal de Saúde, garantindo transparência e participação social. Entretanto, foram identificados desafios relacionados à limitação de recursos financeiros e humanos, além de situações emergenciais que exigiram ajustes na execução das ações.

Considerações Finais

A PAS aprovada representa um avanço na organização das ações e serviços de saúde do município, ao alinhar metas realistas e compatíveis com a capacidade de execução da gestão local. A consolidação do processo de planejamento demonstra o comprometimento com a melhoria da qualidade do cuidado prestado à população e o fortalecimento do SUS em âmbito municipal.

Recomenda-se, para os próximos ciclos:

a)Intensificar a qualificação dos sistemas de informação para melhor monitoramento dos indicadores;

b)Ampliar a integração entre os diferentes níveis de atenção e vigilância em saúde;

c)Garantir maior investimento em educação permanente das equipes;

d)Buscar estratégias para captação de recursos complementares e otimização da aplicação orçamentária;

e)Fortalecer ainda mais a participação do controle social no acompanhamento da execução da programação.

Conclui-se que a execução da Programação Anual de Saúde aprovada constitui importante instrumento de gestão, sendo fundamental a continuidade do processo avaliativo e a retroalimentação com vistas ao próximo ciclo de planejamento.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021. Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 10/06/2026.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo FNS/SE/MS.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção
Não há dados para o período informado

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 23/05/2026.

9.2. Indicadores financeiros

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 23/05/2026.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

Não há informações cadastradas para o período do Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar.

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

  As atividades de Saúde do Município de Ibema são financiadas por recursos Federais mediante convenio e repasse Fundo a Fundo; os planos de convênios foram repassados conforme cronograma de desembolso financeiro do Governo Federal e foram utilizados de acordo com o plano de aplicação pactuado;

PLANO DE APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DA SAÚDE A PARTIR DE MARÇO 2026

RESOLUÇÃO	*VALOR GASTO*	*PRODUTO*	*SALDO*
RESOLUÇÃO 374/24 PROVIGIA	3.599,90	01 NOT BOOK	**29.375,59**

RESOLUÇÃO 870/2021 FISIOTERAPIA	19,977,87	21 FAIXA DE ALONGAMENTO 22 KIT DE FAIXA DE INTENSIDADE 05 CADEIRAS DE RODAS ADULTO 02 MESA AUXILIAR 01 BICICLETA ERGOMETRICA 20 PARES DE MOLETA ADULTO 06 BENGALAS 10 KIT DE FISIOTERAPIA PULMONAR 10 EXERCITADOR DE DEDOS E MAOS 10 EXTERSOR ELASTICO PARA EXERCICIOS DE DEDOS 10 BOLAS DE CRAVO MASSAGEM 01 MINI BYKE PORTATIL 05 ESFIGMOMANOMETRO 05 ESTETOSCOPIO 07 ANDADOR 02 CADEIRA DE RODAS INFANTIL 04 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	**22,13**
RESOLUÇÃO 860/22 ATENÇÃO BASICA	30.000,00	02 NOTBOOK 02 CAMA DE EXAME GINECOLOGICO 04 POLTRONA RECLINAVEL 02 CARRINHO CURATIVO 05 ESFIGNMANOMETRO 05 ESTETOSCOPIO 05 LANTERNA CLINICA 03 DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS 02 OTOSCOPIO 01 ARMARIO DUAS PORTAS 02 IMPRESSORA 10 KIT INALAÇÃO 02 OXIMETRO DE PULSO DE MESA 09 OXIMETRO PORTATIL	**1.277,13**
RESOLUÇÃO 1450/25 IOAF	6.207,00	06 LONGARINA 01 ESCADA DOBRAVEL 01 ESCADA MULTIFUNCIONAL 01 ESTRADO	**807,00**
IOAF	1.889,18	02 LONGARINA	**89,18**
RESOLUÇÃO 1712/24 IOAF	185,00	03 ESTRADO	**11,00**

RESOLUÇÃO 860/22	25.000,00	04 MOCHO ODONTOLOGICO 02 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA 01 COMPRESSOR 01 FOTOPOLIMERIZADOR LED 02 IMPRESSORA 01 ARQUIVO DE AÇO	**12.160,33**
RESOLUÇÃO 605/24 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.000,00	05 TABLET	**4.505,00**
VIGIASUS	1.581,38	01 MESA DE AÇO INOX 03 SUPORTE PRA BANNER	**88,38**
RESOLUÇÃO 808/22 PROVIGIA	28.488.86	01 SUPORTE PRA BANNER 02 MESA TIPO ESCRIVANINHA 01 CADEIRA LONGARINA 04 CADEIRAS PARA COZINHA 01 LIQUIDIFICADOR 01 PROJETOR MULTIMIDIA 01 CAIXA DE SOM PORTATIL 03 ARMARIO DE AÇO 04 ESTANTE DE AÇO 05 CADEIRA DE ESCRITORIO 01 FREEZER HORIZONTAL 02 NOTBOOK	**1.467,06**
RESOLUÇÕES 788/22, 1309/20, 1016/21, 724/19, 1472/23 IOAF	696,40	06 ESTRADO	**348,40**

PLANO DE APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DA SAÚDE A PARTIR DE ABRIL 2026

RESOLUÇÃO	*VALOR GASTO*	*PRODUTO*	*SALDO*
RESOLUÇÃO 374/24 PROVIGIA	29.375,59	01 AR CONDICIONADO 12MIL BTU 01 IMPRESSORA COLORIDA	**24.385,60**
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ¿ FEDERAL	5.923,24	01 NOTBOOK 02 IMPRESSORAS	**343,66**
ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇO DE APS ¿ EMENDA INDIVIDUAL	167.973,92	02 IMPRESSORA COLORIDA 02 NOTBOOK 06 AR CONDICIONADO DE 9MIL BTU 02 AR CONDICIONADO DE 36MIL BTU 01 AR CONDICIONADO DE 12MIL BTU	**116.161,21**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ADITIVOS DA SAUDE	25.609,09	01 FREEZER	**22.429,09**

EMENDA IMPOSITIVA	125.500,00	04 CADEIRAS GIRATÓRIAS 03 CAMA HOSPITALAR ELETRICA 01 AR CONDICIONADO DE 10MIL BTU 15 AR CONDICIONADO DE 9MIL BTU 01 TV SMART DE 43 POLEGADAS 10 TV LED SMART DE 32 POLEGADAS	**32.534,19**

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 10/06/2026.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 10/06/2026.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

nao houve

11. Análises e Considerações Gerais

Apresentado neste relatório os resultados qualitativos e quantitativos no processo do cuidar da saúde, acompanhado e avaliado os indicadores no 1º quadrimestre de 2026.

EROILDA ALVES DE OLIVEIRA
Secretário(a) de Saúde
IBEMA/PR, 2026

Parecer do Conselho de Saúde

Identificação

- Considerações:

  APROVADO

Introdução

- Considerações:

  APROVADO

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

  APROVADO

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

  APROVADO

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

  APROVADO

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

  APROVADO

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

  APROVADO

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

  Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

  APROVADO

Auditorias

- Considerações:

  NÃO HOUVE

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

  SEM CONSIDERAÇÕES

Status do Parecer: Avaliado

IBEMA/PR, 10 de Junho de 2026

Conselho Municipal de Saúde de Ibema